

«Бронхіальна астма»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- Виконати аускультатию легень.
- Оцінити аналіз на мокротиння.
- Описати спірометрію.
- Встановити попередній діагноз.
- Визначити тактику ведення та лікування.
- Означити рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя.

2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції з пакетами додаткових матеріалів:

- Сценарій «Діагностика та подальша тактика ведення і лікування хворого з діагнозом бронхіальна астма».

Ви лікарка-терапевт терапевтичного відділення. До Вас звернулася жінка, 30 років, продавчиня

Скарги: на напади ядухи з утрудненим видихом, які закінчуються кашлем з відходженням невеликої кількості прозорого мокротиння.

Анамнез захворювання: хворіє протягом 18 років. Напади виникають до 3 разів на тиждень, нічні напади – 2 рази на місяць. Постійно приймає симбікорт 160/4,5 2 рази на день. Погіршення стану у вигляді почастишання нападів задухи в денний час до 5 на день, відмічає протягом останніх 2 днів.

Анамнез життя: Алергійні реакції та непереносимість ліків – кропив'янка на амброзію. Спадковість: бабуся хворіє на бронхіальну астму.

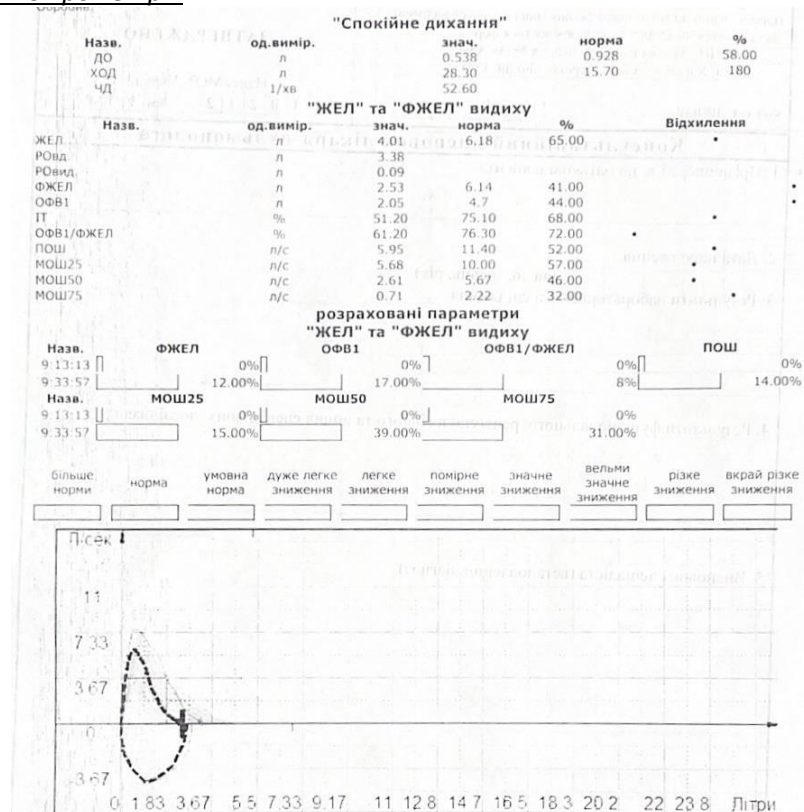
Об'єктивно: стан середньої тяжкості, свідомість ясна. Шкіра бліда, помірний ціаноз губ. Периферичних набряків немає. ЧДР 24 за 1 хв. SpO2 96 %. Тони серця звучні, ритмічні. АТ 130/85 мм рт.ст. ЧСС=PS=90 уд. за 1 хв. Живіт м'який, безболісний. Печінка не збільшена. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

- Додаток 1 Аналіз мокротиння.

Показник	Результат	Норма
Кількість за добу, мл	40	10-100
Запах	немає	Відсутній
Шаруватість	Відсутня	Відсутня
Реакція (рН)	Лужна	Нейтральна або лужна
Характер	Слизовий, в'язка	Слизовий
Мікроскопія		
Нейтрофіли	-	
Еозинофіли	наявні	
Еритроцити	-	

Плоский епітелій	10-12 в полі зору	
Альвеолярні клітини	12-15 в полі зору	
Спіралі Куршмана	наявні	
Кристали Шарко-Лейдена	наявні	
Атипові клітини	немає	
МБТ	немає	

• Додаток 2 Спірометрія



Висновок: ФЖЕЛ -41%, ОФВ1 – 44%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 72%. Значні порушення легеневої вентиляції за змішаним типом. Проба з бронходилататором: – приріст ОФВ1 17%.

3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції.

Ви зібрали скарги, анамнез захворювання та життя, провели об'єктивне обстеження:

Алгоритм дій здобувача.

	Дії здобувача освіти
1.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):	
	інформовану згоду отримано;

	руки оброблено на гігієнічному рівні.
2.ВИКОНАННЯ НАВИЧКИ «ПОРІВНЯЛЬНА ПЕРКУСІЯ ЛЕГЕНЬ»	
	Аускультация легень: симетричність (аускультацию проводити на симетричних ділянках грудної клітки, у кожній точці аускультатії вислуховувати 2-3 дихальних цикли).
	Аускультация легень: коректна послідовність спереду (у місці розташування серця легені не вислуховувати)
	Аускультация легень: коректна послідовність в пахвинних ділянках (при аускультатії в бічних відділах просять хворого поставити руки на пояс)
	Аускультация легень: коректна послідовність позаду (при вислуховуванні ззаду просять злегка нахилитися вперед і схрестити руки на грудях (для розбіжності лопаток)
	Аналіз основних та побічних дихальних шумів: над всією поверхнею легень вислуховується жорстке дихання, росіяни сухі хрипи.
	Самопочуття пацієнта задовільне
3. ДІАГНОСТИКА:	
<i>Оцінити аналіз мокротиння</i> (Додаток 1)	В аналізі наявні еозинофіли, спіралі Куршмана та кристали Шарко-Лейдена, що притаманне бронхіальній астмі.
<i>Описати спірометрію</i> (Додаток 2)	Значні порушення легеневої вентиляції (ФЖЄЛ -41%, ОФВ1 – 44%, ОФВ1/ФЖЄЛ – 72%.) свідчать про бронхообструктивний синдром. Проба з бронходилататором: – приріст ОФВ ₁ 17% свідчить на користь бронхіальної астми.
<i>Встановити попередній діагноз:</i>	Бронхіальна астма, атопічна форма, персистуюча, середньої важкості, неконтрольована.
4.ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ	
<i>Призначено наступні ліки:</i>	Інгаляційні глюкокортикоїди/β-агоніст тривалої дії - серетид Бронходилататор за потреби сальб Антагоністи лейкотрієнів - монтелукаст
5. Профілактика та пропаганда здорового способу життя:	
	Уникати провокуючих факторів ядухи. Імунізація